

Gynéco-Obstétrique — Sujet n°3 (SF L2)

EVALUATION DES ELEVES SAGE-FEMME

NIVEAU L2

SUJET NO 3

QUESTIONS A CHOIX DIRECT : Répondre par Vrai (V) ou Faux (F)

La première échographie du premier trimestre pour la confirmation de la grossesse doit être réalisée à partir de la 20ème semaine d'aménorrhée F

Le sulfate de magnésium permet la prévention de la crise d'éclampsie V

Dans la Grossesse molaire les signes sympathiques de la grossesse sont exacerbés V

Un liquide amniotique méconial pendant le travail d'accouchement traduit toujours une souffrance fœtale aigue F

L'offre d'une méthode de contraception fait partie des soins après avortement V

La trompe intervient dans la production de la glaire cervicale F

La CPN du 2e trimestre permet d'évaluer le pronostic d'accouchement par voie F

La SFC survient toujours au cours du travail d'accouchement F

L'avortement précoce est l'expulsion du produit de conception avant 22 SA F

L'anémie au cours de la grossesse se définit par un taux d'hémoglobine <10,5 grs /100 ml au 1er et 3ème trimestre de la grossesse F

La crise d'éclampsie peut survenir après un accouchement V

Dans le placenta prævia associé à des métrorragies modérées, la césarienne s'impose en urgence F

Une patiente ayant accouché une fois par césarienne devra obligatoirement accouché par césarienne lors de ses prochaines grossesses F

L'AMIU est plus efficace que la méthode médicamenteuse dans la prise en charge des avortements avant 12 semaines. V

La carence en vitamine B12 est à l'origine d'une anémie hypochrome microcytaire V

La primiparité n'est pas un facteur de risque de grossesse prolongée F

En cas d'HRP avec des métrorragies minimales, il est impératif d'hospitaliser la patiente pour une surveillance materno-fœtale F

En cas de placenta prævia, la césarienne s'impose en urgence F

L'anémie est dite légère au cours de la grossesse lorsqu'elle est comprise en 8 et 10 g/dl F

En cas d'anémie hypochrome microcytaire, la cause la plus fréquente est la carence en acide folique F

QUESTIONS A CHOIX MULTIPLE : Choisissez la ou les bonnes réponses

En cas de placenta prævia, l'interrogatoire retrouvera (cochez les bonnes réponses) :

Notion de HTA

Antécédent de curetage

Saignements antérieurs au cours de la grossesse

Contractions utérines permanentes

Devant un HRP, l'examen physique retrouve le plus souvent :

Œdèmes aux membres inférieurs

Présence et régularité des BDCF

Etat hémodynamique en rapport avec les saignements

Toucher vaginal devant être réalisé avec prudence

Quels sont les complications liées à l'HRP :

Choc hypovolémique

Atonie utérine

Fièvre

Décès

Parmi les signes suivants, lesquels sont en faveur d'un syndrome de prérupture :

Utérus déformé en sablier

Etat de choc en rapport avec les saignements

Fœtus palpé sous la peau

Disparition des contractions utérines

Segment inférieur tendu en sébile de bois

Dans quelle pathologie le risque de coagulopathie est-il le plus important (cochez la bonne réponse) :

Placenta praevia

Hématome Rétro Placentaire

Rupture utérine

Citez deux causes fœtales de prématurité

Hydramnios

Grossesse multiple

Oligoamnios

Malformation fœtale

En cas de placenta praevia on peut retrouver les signes suivants :

HU excessive

Signes de choc non en rapport avec les saignements

Col cerclé

Perception d'un matelas placentaire

Identifiez les mécanismes de l'anémie chez la femme enceinte :

Carence alimentaire

Régime pauvre en fibres

Troubles digestifs de l'absorption

Croissance fœtale

Les complications fœtales de l'anémie sont :

La menace d'accouchement prématuré

Le retard de croissance intra utérin

Les présentations dystociques

La mort fœtale

Parmi les éléments suivants, lesquels ne font pas partie de la GATPA :

Massage utérin

Traction contrôlée du cordon

Révision utérine

Vidange vésicale

Injection de 5UI de Syntocinon en IM

Parmi les causes suivantes de menace d'accouchement prématuré, cochez les deux causes générales :

Diabète

HTA

HRP

Grossesse multiple

Fibrome utérin

Dans l'association paludisme et grossesse : trouver la réponse fausse

C'est une cause d'avortement spontané

Le traitement peut utiliser les CTA au 1er trimestre

Les antipyrétiques sont contre-indiqués

Les facteurs de risque du diabète gestationnel sont : trouver les 2 réponses justes

Femme âgée de plus de 35 ans

Antécédents d'accouchement prématuré

HU excessive

Les complications du diabète gestationnel sont : trouver les 2 réponses justes

RCIU

Macrosomie

Grossesse prolongée

Dystocie des épaules

Concernant l'épisiotomie, quelle est la réponse exacte :

Doit être précédée d'une toilette périnéale

Est le plus souvent médiane

Est obligatoire chez une primigeste

La technique de réparation la mieux indiquée est celle des points séparés

Les contre-indications du déclenchement artificiel du travail sont: trouver les 2 réponses justes

Fœtus en siège

Utérus cicatriciel

HTA

SFA

Le score de Bishop est établi grâce aux éléments suivants : trouver la réponse inexacte

La longueur du col

La variété de présentation

La hauteur utérine

Le niveau de la présentation

Les hémoglobinopathies les plus fréquentes en CI sont : trouver les 2 réponses justes

La thalassémie

La sphérocytose

La drépanocytose

Dans les Grossesses Gémellaires uni ovulaires : trouver la réponse juste

Les foetus peuvent être de sexe différent

Est toujours monochoriale et bi amniotique

Peut aboutir à des siamois

Ce sont les faux jumeaux

Quels sont les propositions exactes concernant l'accouchement gémellaire : trouver la réponse inexacte

Il se déroule en 3 temps

La phase de rémission ne doit pas excéder 15 minutes

La voie basse est toujours indiquée lorsque j1 est en siège

Est une facteur de risque d'hpp